

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	單位間交班程序				
	The Unit between Units Standard Operating Procedure of Shift Change Handover				
編號	A31000-Q02-W-F06	制定者	CCU 林涵蓁	公布日期	95 年 04 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.8 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解單位間交接程序。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 交班內容使用結構化溝通模式-ISBAR 應包括

1. Introduction 介紹：向接班者自我介紹及確認交班對象。確認病人姓名、床號、病歷號、年齡、生日等辨識病人的項目。
2. Situation 情境：病人現況或觀察到的改變。包括現存之健康問題：病人最近情況的改變。
3. Background 背景：重要病史、目前用藥。包含病人基本資料：入院日期、年齡、診斷、語言、主要照顧者及重要人物、與家屬的聯絡方式、過去病史、入院原因、現在病史、過敏史、病人是否酗酒、吸毒、暴力傾向及色情行為者。
4. Assessment 評估：護理評估、診斷、措施、評值，目前治療與用藥情形，各項檢查及檢驗之日期、結果，以及異常檢驗值及醫師處理情形，尚待處理的狀況、需要追蹤的檢查結果、醫師是否更改醫囑及有無特別之處方。手術及麻醉方式、日期及傷口情形、特殊管路和裝置。兒科病童需交班每日排泄情形及進食狀況，心臟疾患、腎臟疾患則需交班 I/O 及 BW。

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	2/9

5. Recommendation 建議：後續處理措施或方向、病人特殊狀況：病人出院、轉院、轉床及請假需交班清楚；自備物品；可能發生危急狀況的預防、如情緒不穩定、自殺傾向，以及精神疾病者須特別交班，以預防可能發生的意外。

(二) 交班時有任何疑問時，可隨時提出發問並予以澄清與說明，交班人員對病情應完全了解，特殊事項應交班清楚，過程中有任何不清楚或疑慮的地方，應主動提問，交班人員應當下回以釐清問題，維護交班完整與即時性。

(三) 確實檢視病人：交接班前後須確實核對病人身份、身體評估、傷口大小、身上留置的管路和裝置及滴注用藥。

(四) 單位間交班內容重點參考如下

1. 經門診辦住院之病人：

門診護理人員依病人此次主要診斷、就診情形（已做了哪些檢查、處置...）說明此次入院原因。

2. 單位間病人送檢查室或會診

(1) 依個案診斷、檢查、特殊狀況等進行交班。

(2) 住院病人若發生異常事件（例如：疑似跌倒），至治療室行復健治療前需先口頭交班。

(3) 病人到血液透析室執行血液透析時，必須填寫運送安全交班，血液透析室須與病房完成交班後，方可進行血液透析作業。

3. 單位間轉床（含加護單位）

依 HIS 住院護理系統護理交班頁面進行交班，另依藥品移交總表，將藥物逐項對點交班，高警訊藥物需使用「高警訊藥物點交記錄表」，若轉出（入）加護病房或轉至不同科別時，至轉入單位並進行雙人核對後留存於單位。

4. 手術病人轉加護單位或麻醉恢復室

(1) 手術室護理人員依「手術室護理記錄」之診斷、手術方式、引流管、醫師交代特殊事項（如塞紗）等交班。

(2) 麻醉科人員依「麻醉紀錄」、「麻醉科交班紀錄」中之麻醉方式、意識、生

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	3/9

命徵象、管路、現行用藥、輸出輸入量（靜脈注射量、失血量、輸血量、尿量）等交班。

(3) 病人如由病房入手術室開刀，開刀後轉回非原單位，則原（轉出）單位依 HIS 住院護理系統護理交班頁面進行交班，另依藥品移交總表，將藥物逐項對點交班，高警訊藥物需使用「高警訊藥物點交記錄表」，若轉出

（入）加護病房或轉至不同科別時，至轉入單位並進行雙人核對後留存於單位。

(4) 病人如由急診室入手術室開刀後轉至加護單位，則由急診室人員與手術室人員依 HIS 系統急診護理交班頁面進行交班、手術後由手術室人員與加護單位進行交班。

5. 麻醉恢復室病人轉加護單位或病房

麻醉恢復室人員依「恢復室紀錄」、「恢復室交班紀錄」中診斷、手術方式、麻醉方式、意識、生命徵象、引流管、管路、輸出輸入量（靜脈注射量、失血量、輸血量、尿量等）、醫師交代特殊事項（如塞紗）交班。

6. 產房產婦轉病房

自然產/剖腹產：依 HIS 系統護理交班頁面及特殊用藥進行交班。

7. 產房新生兒轉嬰兒室

依 HIS 系統「分娩記錄」（懷孕週數、分娩方式、胎次、分娩時特殊情況...）、「新生兒出生記錄」（出生年月日及時間、新生兒性別、A/S、大小便情況、HBsAg、HBeAg 報告須附『孕婦 B 型肝炎產前檢查登錄表』，HIV、GBS 及其他感染疾病等的報告，由產房將嬰兒放置在嬰兒車或保溫箱，推嬰兒至兒科部門(BR、IR、NI)者，與兒科部門交班者共同核對電腦之檢驗報告、出生時異常處置...) 交班。

8. 嬰兒室轉加護單位

依 HIS 住院護理系統護理交班頁面進行交班。

9. 急診室入院至病房/加護病房

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	4/9

依 HIS 系統急診護理交班頁面進行交班，轉送交班過程中若有發生異常，則至異常事件通報系統進行通報，並完成後續改善追蹤。

(五) 病人入住各單位狀況之運送及交班原則：病人運送請以 A31000-Q02-W-F07 運送病人之作業標準，各單位交班使用結構化溝通模式-**ISBAR** 進行，以下針對病人入手術室、心導管室、心導管檢查之緊急手術之運送、處置及交班進行再詳細說明，若確定轉床至其他病房，則原病房應立即交班，以利床位運用。

1. 病人入手術室之運送及交班：急診或病房病人手術後至病房，以最後要入住病房接病人，若至加護病房，則病人由手術室運送至加護病房，但若病人於手術室或麻醉恢復室需緊急送檢查室，則會由手術室或麻醉恢復室之醫護人員送至檢查室，並聯絡原單位及最後要入住病房的醫護人員一同至檢查室交班，並由最後要入住病房的醫護人員協助運送回入住病房。

範例 1：ER 訂 N13 病房→OR→POR→臨時決定轉 N14 病房，因 N14 為最後入住病房，故需至 POR 接病人且 POR 需與 N14 病房交班

範例 2：N13 病房→OR→POR→又轉 N14 病房，因 N14 為最後入住病房，故需至 POR 接病人，N13 病房與 N14 病房可電話交班

範例 3：ER 訂 N13 病房→OR→臨時決定 ICU，由 OR 將病人送至 ICU 並交班

範例 4：N13 病房→OR→ICU，由 OR 將病人送至 ICU，N13 病房與 ICU 可電話交班

2. 病人入心導管室運送及交班：由已完成訂床單位接病人至下一個單位，若心導管再至手術室轉加護病房，則病人由手術室運送至加護病房。

範例 1：ER 已訂 N13 病房→心導管室→臨時決定轉 ICU，因 N13 病房為「已完成訂床單位」，故由 N13 至心導管室接病人至 ICU，交班流程則為 ER 通知 N13 病房一同在心導管室交班，最後由病房與加護病房交班

範例 2：ER 已訂 MICU→心導管室→臨時決定轉 CCU，因 MICU 為「已完成訂床單位」，故由 MICU 至心導管室接病人至 CCU，交班流程則為 ER 通知 MICU 一同在心導管室交班，最後由 MICU 與 CCU 交班

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	5/9

範例 3：N13 病房→心導管室→臨時決定轉 ICU，情況如上，故由 N13 至心導管室接病人至 ICU 並交班

範例 4：N13 病房→心導管室→前一天預訂並已完成訂床至 ICU，因 ICU 為「已完成訂床單位」，故由 ICU 至心導管室接病人，此時病房可與 ICU 電話交班

範例 5：ER 訂 CCU→心導管室檢查→OR→臨時轉 SICU，由 CCU 進行術前準備，手術後由 OR 運送病人至 SICU，CCU 與 SICU 可電話交班

範例 6：N13 病房→心導管室→OR→ICU，由 N13 進行術前準備，手術後由 OR 運送病人至 ICU，N13 與 ICU 可電話交班

（六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

（略）

七、附件

（略）

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	6/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
95.04.30	1.0	新制定	95 年 04 月 30 日 護理部照護標準 委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
99.09.08	2.1	病人交班及接送以病人入住最後單位為主，於 2010 年 8 月 12 護理長會議通過，「病人入住狀況之運送及交接原則」，共有 11 項情況，即日起立即實行，但第 8 項情況將暫試行三個月，於 99 年 12 月 1 日再進行討論（附件一），如遇未列入之特殊狀況則另議。	2010 年 8 月 12 護 理長會議通，「病 人入住狀況之運 送及交接原則」過
101.08.15	2.2	修改說明內容	101 年 08 月 15 日 護理部照護標準 委員會通過
101.12.05	2.3	將單位間交班原則(附件一)內容：病人入住狀況之運送及交接原則加到 SOP 內容裡	101 年 12 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.12.03	3.1	說明(四)9.新增：HBsAg、HBeAg 報告須附『孕婦 B 型肝炎產前檢查登錄表』，HIV、GBS 及其他感染疾病等的報告由產房抱嬰兒至兒科部門(BR、IR、NI)者，與兒科部門交班者共同核對電腦之檢驗報告	102 年 12 月 03 日 護理部照護標準 委員會通過
103.02.19	3.2	說明(四)2.新增：住院病人若發生異常事件(例如：疑似跌倒)，至治療室行復健治療前需先口頭交班	103 年 02 月 19 日 護理品質照護管 理委員會決議通 過
103.08.05	3.3	1. 說明內容部份修辭。 2. 經 103 年 7 月 9 日護理長會議決議，將說明（五）病人入住狀況之運送及交接原則部份內容修正。	103 年 08 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過
104.08.04	3.4	第三項第(四)目之 4 新增：若轉出（入）加護病房或轉至不同科別時，需由轉出單位人員填寫「轉出（院）護理照護摘要單」。	104 年 08 月 04 日 護理部照護標準 委員會通過

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	7/9

修正日期	版本	修正說明	備註
105.04.07	3.5	原第三項第(二)目：交班時有任何疑問時，可隨時提出發問並予以澄清與說明因。 105 年病人安全目標新制定規範針對單位間交班作業標準。更改為~交班人員對病情應完全了解，特殊事項應交班清楚，過程中有任何不清楚或疑慮的地方，應主動提問，交班人員應當下回以釐清問題，維護交班完整與即時性。	105 年 04 月 07 日 護理部照護標準委員會通過
105.06.07	3.6	第三項第(四)目之 2(3) 新增：病人到血液透析室執行血液透析時，必須填寫病人轉送交班單，血液透析室須與病房完成交班後，方可進行血液透析作業。	依據異常事件通報案號 AE10505001 提出修正，於 105 年 06 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.02	3.7	1. 主題名稱英文標題修正~刪除：Between The Unit Passes On TO The Next Shift The Principle 改為~The Principle of Medical History Taking Between Units。 2. 因電子化第三項第(四)目之 3、4、5、6、7、8 刪修部分內容。 3. 新增第六項參考文獻資料。 4. 情況 1-13 加上範例	105 年 08 月 02 日 護理部照護標準委員會通過
105.10.04	3.8	第三項第(五)目病人入住狀況之運送及交接原則部份內容增修。	105 年 10 月 04 日 護理部照護標準委員會通過
105.12.06	3.9	1. 原第三項第(五)目病人入住狀況之運送及交接原則，刪修為~病人入住各單位狀況之運送及交班原則。 2. 增修病人入手術室之運送及交班範例；病人入心導管室運送及交班範例等內容。	105 年 12 月 06 日 護理部照護標準委員會通過
106.04.10	4.0	因應醫療品質暨病人安全委員會制定全院性之「交班作業規範」，並決議其他交班規範更名為交班程序；故主題名稱及目的刪除：單位間交班原則，改為~單位間交班程序。	106 年 04 月 10 日 護理部照護標準委員會通過
106.05.10	4.1	第三項第(四)目之 9 增修為急診室入院至病房/加護病房：依急診病歷及急診護理記錄執行交班(診斷、主訴、處置過程及結果)，並填寫急診轉送護	106 年 05 月 10 日 護理長會議決議通過

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
		理交班單，由轉入單位留存於病歷。轉送交班過程中若無異常時，即由轉入單位存檔 3 個月；轉送交班過程中若有發生異常，則至異常事件通報系統進行通報，並完成後續改善追蹤。	
106.08.07	4.2	依據 106 年 6 月 6 日督導會議決議修正 1. 說明(一)使用結構化溝通模式- ISBARI 修改為 ISBAR，刪除說明(一)6.向病人自我介紹，確認病人姓名、床號、病歷號、生日等辨識病人的項目。 2. 說明(五) ISBARI 修改為 ISBAR。	106 年 08 月 07 日 護理部照護標準委員會通過
107.06.29	4.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.08.08	4.3	第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 08 月 08 日 照護標準組會議通過；108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	4.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	4.4	第六項新增三份參考文獻資料。	110 年 08 月 05 日 照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	4.5	第三項第四目之 3.及 4.(3)刪除若轉出（入）加護病房或轉至不同科別時，需由轉出單位人員填寫「轉出（院）護理照護摘要單」。	111 年 08 月 04 日 照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。

主題名稱	單位間交班程序	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-F06	版本	第 4.8 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
112.09.05	4.6	1. 第三項第四目之 9.刪除急診轉送護理交班單，由轉入單位留存於病歷。轉送交班過程中若無異常時，即由轉入單位存檔 3 個月。 2. 第三項第五目之 2.範例 4.由 CCU 交班給 SICU 修訂為 CCU 與 SICU 可電話交班。 3. 第六項參考資料部份刪除。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過;112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.03.19	4.7	1. 第三項第四目之 2.3.4.5.6.8.9.單位間交班重點內容說明修訂。 2. 第三項第五目之 2.範例 4.說明修訂。	113 年 02 月 01 日照護標準組會議通過;113 年 03 月 13 日護理長會議通過;113 年 03 月 19 日督導會議通過公布
114.10.08	4.8	第三項第五目第 2 點修改說明內的範例	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過;114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。